31. EL APARATO GENITAL FEMENINO

DURACIÓN : 06:15 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video, exploramos en profundidad el desarrollo del aparato genital femenino, comenzando por la formación de los conductos de Wolff y de Müller, y su impacto en la estructura reproductiva. Se hace hincapié en la relación urogenital que difiere entre el hombre y la mujer, destacando la creación del útero y de las trompas. También profundizamos en el papel de los ligamentos ancho y ovárico, así como en la importancia de la salud renal en la regulación hormonal y la fertilidad. El video aborda la continuidad fascial en la pelvis y cómo anomalías como los fibromas pueden influir en toda la dinámica corporal, proporcionando información crucial para los practicantes de osteopatía y desarrollo embrionario.

EL APARATO GENITAL FEMENINO

1. CONDUCTO MESONEFRÓTICO (CONDUCTO DE WOLFF) Y PARAMESONEFRÓTICO (CONDUCTO DE MÜLLER)

El **conducto de Wolff**, también llamado **conducto mesonefrótico**, es el primer conducto que aparece en el embrión.

En el hombre, este conducto desciende y se integra entre los testículos para formar el **conducto eyaculador**. En cambio, el conducto de Müller permanece como vestigio y contribuye a la formación del corazón de la próstata.

En la mujer, la situación es inversa:

- El conducto de Wolff se diferencia en **órganos de Gartner**, que son vestigios.
- El conducto de Müller, por fusión, se convierte en el **útero** y las **trompas**.

DESARROLLO UROGENITAL

La relación **urogenital** es fundamental. En el hombre, el conducto epididimario, el conducto deferente y el conducto eyaculador se forman a partir de esta relación.

En la mujer, este desarrollo no ocurre de la misma manera. El conducto de Müller se une hacia la línea central para formar el útero.

Los órganos de Gartner representan los vestigios del conducto de Wolff en la mujer. El conducto eyaculador está orientado hacia la base, y cuanto más se aleja, más formará el útero. Cuanto menos se aleja, más el vestigio será el **utrículo prostático**.

2. EL LIGAMENTO ANCHO Y LOS LIGAMENTOS OVÁRICOS

En el hombre y la mujer, el **peritoneo parietal posterior** se concentra para formar el **ligamento ancho**, así como los pequeños ligamentos ováricos y los ligamentos redondos.

Es el mismo tejido, pero con diferentes concentraciones. Este peritoneo parietal posterior formará el útero en la mujer.

En el hombre, este movimiento no existe, y solo queda una concentración de peritoneo.

3. EL RIÑÓN Y LA SUPRARRENAL

El riñón está situado debajo de la **suprarrenal**, separados por una cápsula. Esto significa que una **ptosis renal** no provoca una ptosis suprarrenal.

Están separados por una fascia llamada la **cápsula de Glisson**. El riñón necesita un espacio graso.

En mujeres muy delgadas, una ptosis del riñón puede provocar irregularidades menstruales y una fertilidad reducida. **Redinamizar un riñón** es también redinamizar su fertilidad.

DESARROLLO EMBRIONARIO DEL RIÑÓN

Inicialmente, en un embrión pequeño, los riñones son enormes, al igual que el hígado. Esto recuerda el desarrollo del cerebro, que está muy desarrollado en comparación con el tronco al principio.

Estas proporciones evolucionan durante el desarrollo. El hígado juega un papel importante en el desarrollo de las suprarrenales.

Esta es la primera vez que se observa una **diferenciación estructural** entre el hombre y la mujer, ligada al mayor desarrollo de las glándulas que crean el **tubérculo de Müller**.

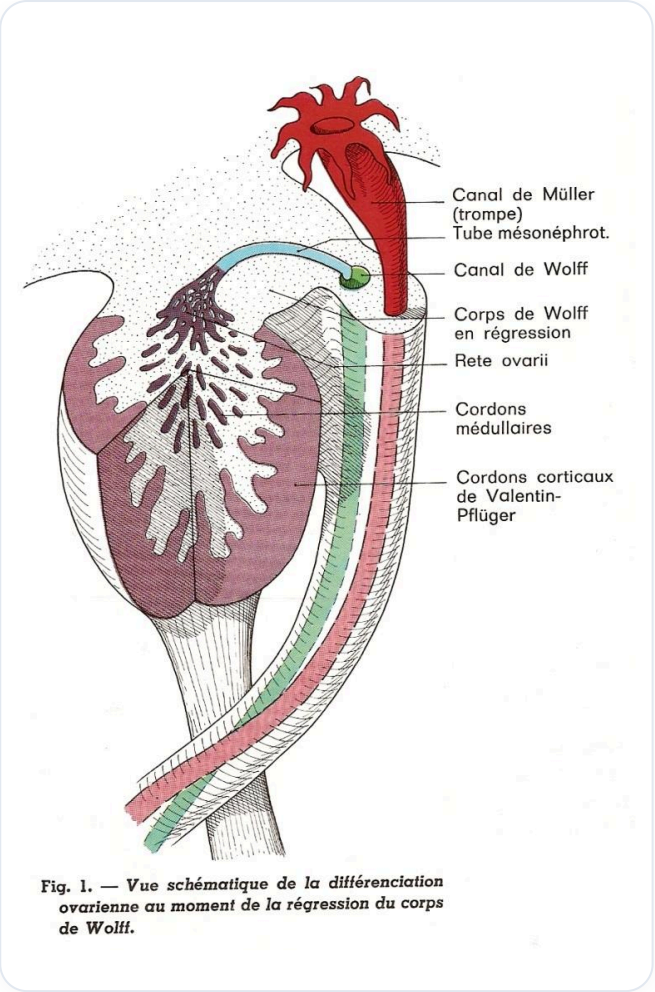


Fig. 1. — *Vue schématique de la différenciation ovarienne au moment de la régression du corps de Wolff.*

FIG. — Diferenciación ovárica

4. DESARROLLO DEL SISTEMA DE MÜLLER (5ª SEMANA)

En la quinta semana, el sistema del lado comienza a desarrollarse, devolviendo toda la potencia al riñón.

El cerebro influye en la formación del corazón, que a su vez establece la **diafragmatización**, el hígado, las suprarrenales, las gónadas y la cresta.

El conducto de Müller se desarrolla mucho más fuertemente en la mujer para crear un conducto puro, que se une para formar el útero.

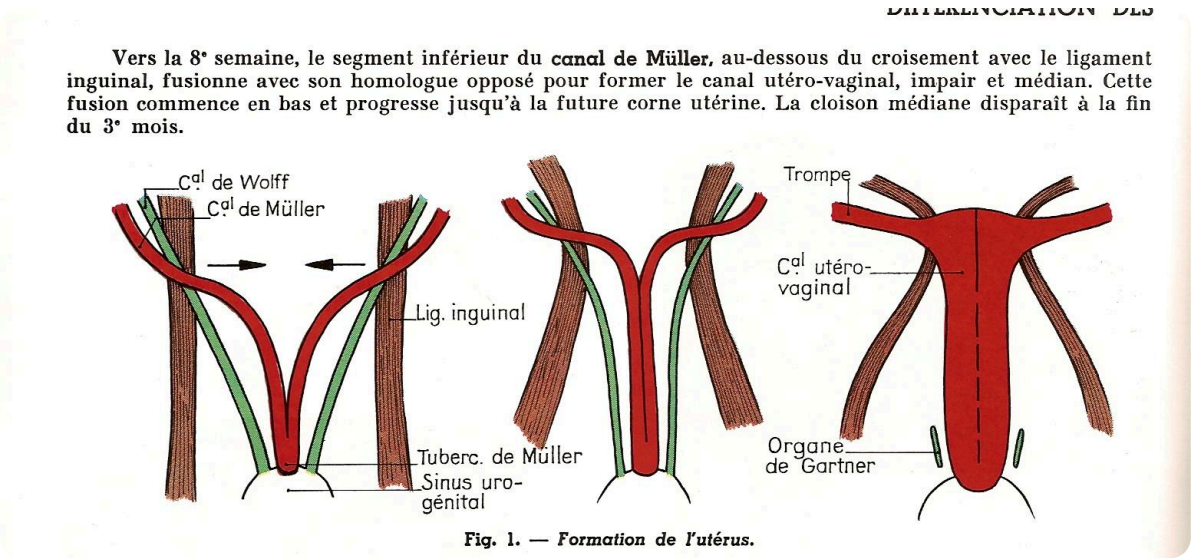


FIG. — Formación del útero embrionario

En el hombre, el desarrollo es menos pronunciado, y lo que queda en la parte inferior del conducto de Müller constituye el corazón de la próstata.

DESCENSO TESTICULAR

El **descenso testicular** se debe a la velocidad de crecimiento diferenciada a nivel del **gubernáculo**, que se ralentiza y tira de todo el sistema.

Esta continuidad fascial entre el útero y toda la parte de la fascia, la piel y la pelvis menor es esencial.

5. CONTINUIDAD FASCIAL E INFLUENCIA DE LAS ESTRUCTURAS

Se observa bien el útero, los ligamentos, los ovarios y la **cavidad peritoneal**.

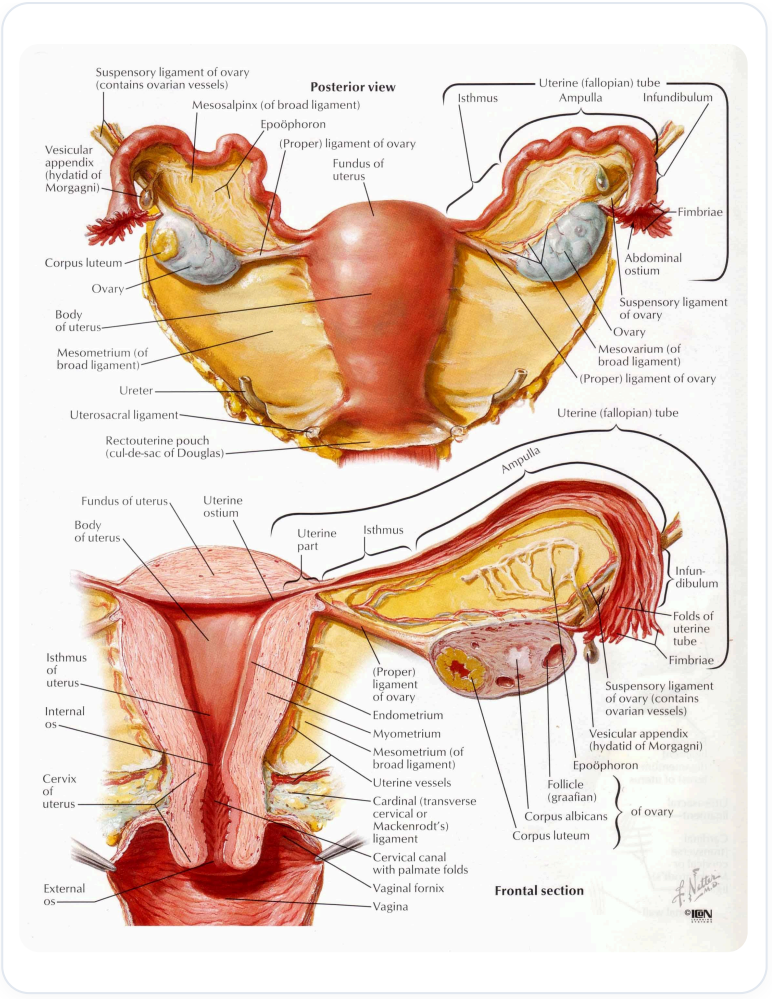


FIG. — Aparato reproductor femenino

Al levantar el útero con pinzas, se observa que todo se mueve.

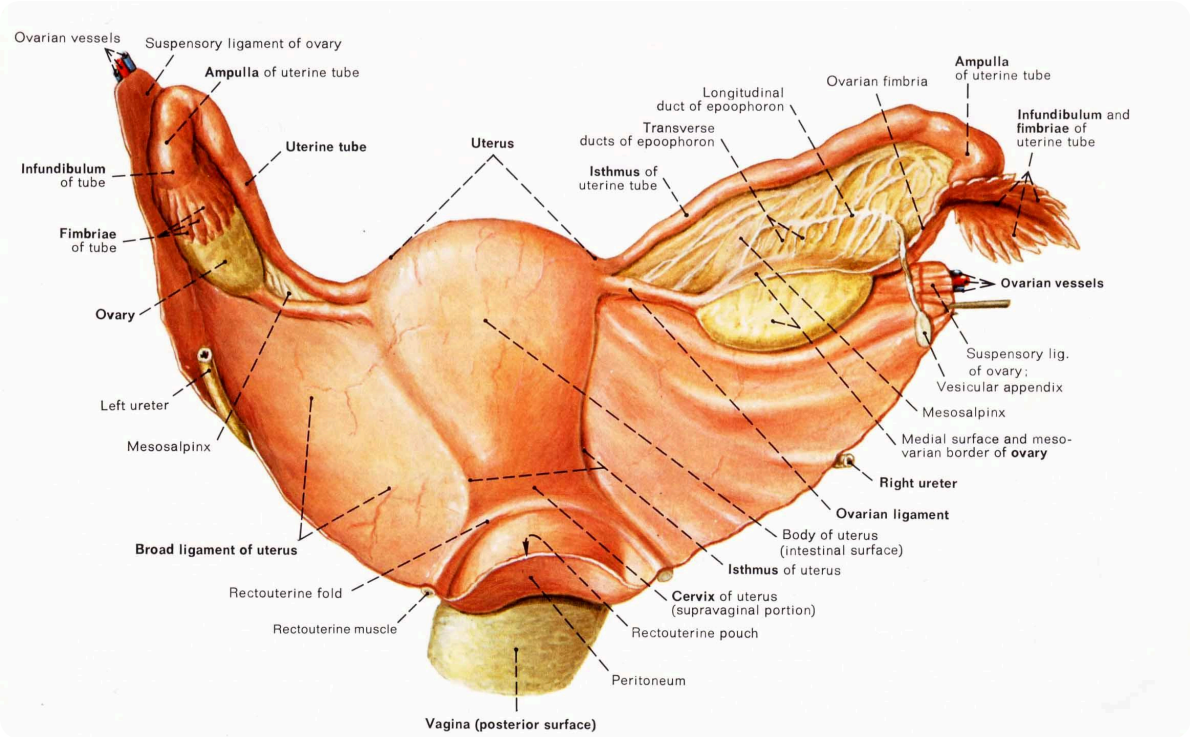


FIG. — Aparato reproductor femenino

El impacto de un **fibroma** o un **quiste** es significativo. La continuidad con los ligamentos es primordial.

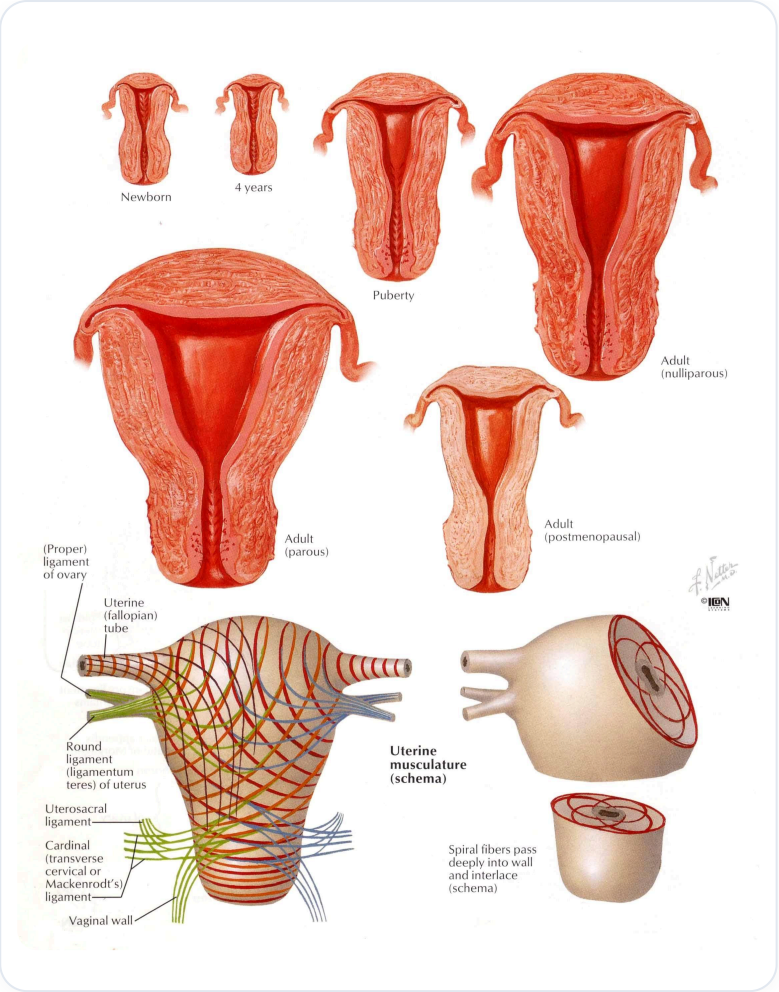


FIG. — Útero y musculatura

Cuando se tira con más fuerza, se puede ver cómo reacciona todo el sistema, incluidos los ligamentos redondos.

El peritoneo es un tejido muy inteligente. La influencia de un fibroma, por ejemplo, puede modificar todo el sistema aguas abajo por una simple tracción.

Un fibroma grande puede provocar una cascada de consecuencias en todo el sistema.

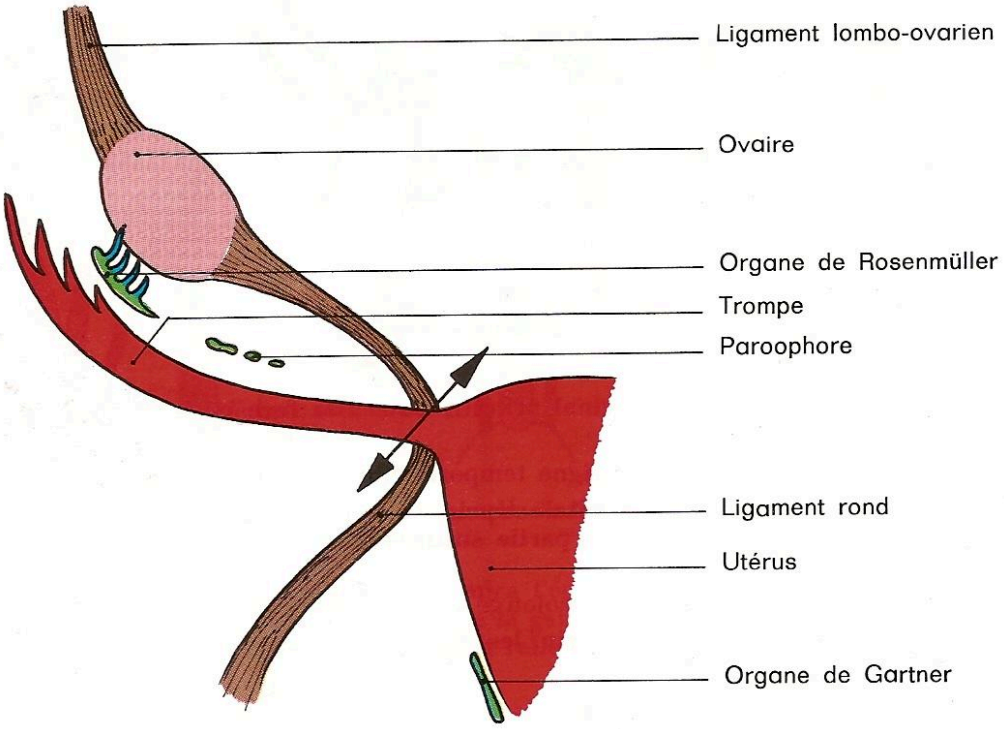
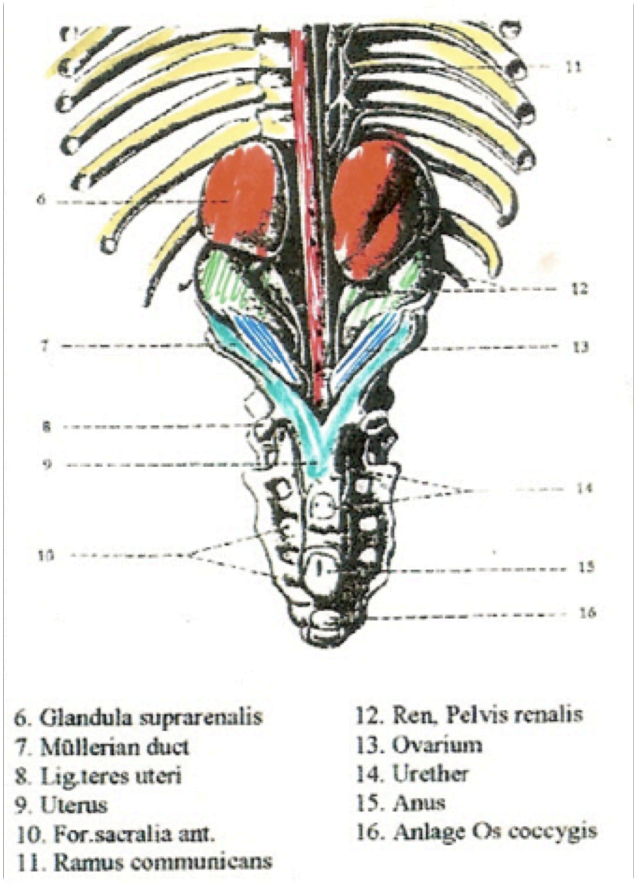


Fig. 1. — *Formation de la trompe et résidus wolffiens.*

FIG. — Órganos genitales femeninos



6. Glandula suprarenalis
7. Müllerian duct
8. Lig.teres uteri
9. Uterus
10. For.sacralia ant.
11. Ramus communicans
12. Ren. Pelvis renalis
13. Ovarium
14. Urether
15. Anus
16. Anlage Os coccygis

FIG. — Aparato genital fetal

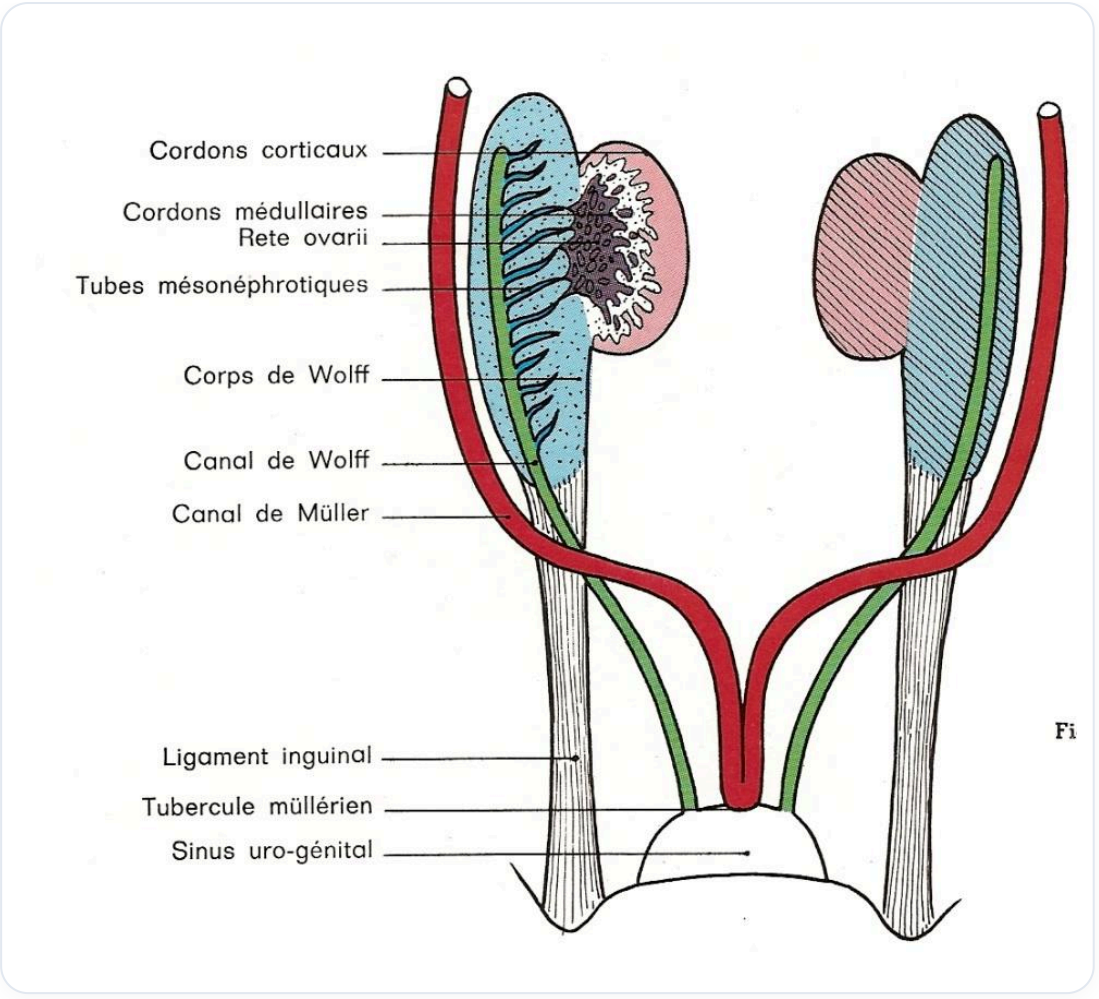


FIG. — Aparato genital indiferenciado